

06 - 01- Traumatismes de l'épaule - Pr El Haoury

Assalamu alaikum, chers étudiants, aujourd'hui nous allons traiter les traumatismes de l'épaule. Nous allons commencer par un cas clinique, il s'agit d'un patient de 24 ans qui se présente aux urgences pour une douleur de l'épaule droite et une appendance fonctionnelle survenue suite à une chute sur la main droite coude en extension lors d'un accident de sport. Alors quels seront les objectifs devant un traumatisme de l'épaule? Donc devant chaque traumatisme de l'épaule il faut connaître l'anatomie de la ceinture scapulaire, il faut savoir examiner l'articulation de l'épaule et de la ceinture scapulaire, interpréter une radiographie de l'épaule, il faut décrire les lésions élémentaires et donc les formes cliniques, les différents types de traumatismes qui peuvent survenir au niveau de l'épaule et bien évidemment comment prendre en charge ces traumatismes ainsi que leurs complications.

Les traumatismes de l'épaule ce sont l'ensemble des lésions osseuses, tendineux musculaires et vasculonerveuse qui peuvent atteindre l'articulation de l'épaule. Ce sont des lésions qui sont fréquentes suite à des accidents de la voie publique voire des accidents de sport. Elles se voient aussi bien chez le sujet âgé suite à des traumatismes minimes du fait de l'ostéoporose ou chez l'adulte jeune suite à des traumatismes à haute énergie.

Le diagnostic est clinique donc un examen clinique minutieux est confirmé par les radiographies. Leur traitement n'est pas univoque, il peut être fonctionnel, orthopédique ou chirurgical. Le complexe articulaire de l'épaule est formé de trois articulations et de deux espaces de glissement.

Les articulations qui forment la ceinture scapulaire ou l'épaule, c'est l'articulation glénohumérale entre la cavité glénoïde de la scapula et la tête humérale, la sternocostoclaviculaire donc entre la clavicule et le sternum et l'acromioclaviculaire donc entre l'acromion de la scapula et la clavicule. Les espaces de glissement sont définis par l'articulation scapulothoracique et l'articulation sous-acromiodeltoïdienne. L'articulation de l'épaule, c'est l'articulation la plus mobile et la plus instable.

Elle doit concilier entre mobilité et stabilité et du fait du faible emboîtement de la tête par rapport à la cavité glénoïde qui la rend très instable, c'est pour cela que les structures capsuloligamentaires vont jouer un rôle important dans le centrage permanent de la tête en regard de la cavité glénoïde. Donc nous avons le labrum, les ligaments et les tendons ainsi que les muscles. La vascularisation de la tête humérale, c'est une vascularisation de type terminale.

Elle est bien vascularisée mais lorsqu'il y a une fracture qui va passer au niveau du col anatomique et va désolidariser la tête par rapport au métaphyse, celle-ci va courir un risque important de nécrose. Donc comme je vous ai dit, les structures capsuloligamentaires jouent un rôle important dans la stabilité de l'articulation glénohumérale. Donc nous avons le labrum, la capsule et les ligaments.

Les ligaments sont en nombre de trois, le ligament glénohuméral supérieur, moyen et inférieur. Le ligament glénohuméral inférieur, c'est le principal stabilisateur de l'épaule lorsque le mouvement d'abduction dépasse les 90 degrés. Donc c'est un véritable hamac sur lequel repose la tête humérale lors du mouvement de l'armée du bras.

Sur le plan anatomopathologique, les différentes structures qui peuvent être atteintes lors des traumatismes de l'épaule, nous avons soit les lésions osteoarticulaires, tendus non musculaires capsuloligamentaires, vasculonerveuse voire cutanée. Et si l'une ou de l'autre structure est atteinte lors des traumatismes de l'épaule, sur le plan physiopathologique, nous allons avoir soit des raideurs, soit des douleurs articulaires, des ischémies ou des paralysies. Donc tout cela va aboutir à une épaule non fonctionnelle, d'où l'intérêt d'un diagnostic adéquat et d'une prise en charge bien adaptée.

Dans ce chapitre, nous allons surtout parler des différentes structures osteoarticulaires les plus fréquentes rencontrées au niveau de l'articulation de l'épaule et qui sont les plus souvent à l'origine des traumatismes. Nous allons voir les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus, fractures de la scapula, les fractures de la clavicule, l'entorse et disjonction sternoclaviculaire, les entorses ou disjonction acromioclaviculaire et la luxation de l'épaule. Nous allons commencer par les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus.

Les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus, c'est toute fracture qui siège au-dessus du bord inférieur de l'insertion du muscle grand pectoral ou pectoralis majeur. Leur analyse radiologique est souvent difficile. Leur répercussion fonctionnelle peut être importante.

Leur traitement n'est pas univoque, il peut être fonctionnel, orthopédique ou chirurgical. La complication la plus souvent rencontrée c'est l'arrêt d'heure de l'épaule. L'examen clinique, il sera commun à toutes les pathologies qui vont suivre et tous traumatismes du membre supérieur.

Notamment à l'interrogatoire, on va rechercher le terrain. Est-ce que c'est un sujet âgé avec un traumatisme minime du fait de l'ostéoporose et c'est surtout le sexe féminin ou c'est un adulte jeune suite à un traumatisme à haute énergie avec un mécanisme lésionnel indirect évocateur. A l'inspection, on va rechercher une attitude des traumatisés du membre supérieur, donc le coude contre le corps, avant bras soutenu par le membre contrôle latéral.

On va rechercher la déformation qui est caractéristique du bras qui va être rapidement masqué par l'œdème post-traumatique. Soit un élargissement du entéro postérieur de l'épaule, soit on va voir un coup d'âge externe, un déficit d'abduction de l'épaule, apparition de l'équimose braquée au thoracique, plus tardivement vers les 48e heure, c'est l'hématome d'énequin. La palpation va rechercher les points douloureux à la palpation de l'extrémité supérieure de l'humérus mais aussi des autres repères osseux notamment l'acromion, la clavicule.

On recherchera des signes négatifs notamment la tête humérale en place pour éliminer

l'alluxation glénohumérale entéro supérieure. Donc on complétera l'examen par la recherche de complications immédiates notamment vasculaire, lésion de l'artère axillaire, elle est rare. Il faut vérifier pour cela systématiquement les poux périphériques et rechercher les signes d'ischémie disto notamment la douleur, la pâleur, le refroidissement, l'hypoesthésie voire l'hépaesthésie.

On va rechercher des signes neurologiques notamment la lésion du nerf axillaire, c'est la complication neurologique la plus fréquente lors du traumatisme de l'épaule. On va étudier la contraction isométrique du deltoïde donc on va demander aux patients de contracter son deltoïde avec des ébauches d'abduction. On va rechercher aussi la sensibilité de la face externe du moignant de l'épaule.

On recherchera aussi les lésions du plexus braquial avec un examen bilatéral comparatif de la sensibilité et de la motricité du membre supérieur. Les lésions exceptionnelles c'est le du nerf radial, musculotendineuse notamment la rupture de la coiffe des rotateurs. On recherchera aussi des lésions cutanées qui seront exceptionnelles par embrochage de la peau par le fragment diaphysaire, donc par lésion de dehors en dedans, qu'au choix 1. Devant ce tableau clinique on demandera des radiographies de l'épaule, de face stricte et de profil.

Le profil il est indispensable mais difficile à obtenir en raison de la douleur. Donc soit un profil axillaire mais celui-ci est pénible pour le patient parce qu'il mobilise le membre fracturé. On demandera soit un profil de l'homoplaque ou un profil transthoracique qui est toujours possible.

Donc le diagnostic radiologique va permettre une étude du trait de fracture ainsi que le déplacement et la recherche de lésions associées notamment ou éliminant par exemple une luxation gléno-humérale. Les radiographies simples parfois elles vont être complétées par un scanner qui permet de détailler et d'affiner l'analyse de la fracture. On déduira ainsi le nombre de fragments, le déplacement dans les différents plans de l'espace.

Le bilan radiologique va permettre d'identifier le trait de fracture et permet de différencier entre les fractures articulaires et les fractures extra-articulaires. Alors concernant les fractures extra-articulaires on va avoir soit des fractures sous-tuborositaires engraînées ou non du col chirurgical, soit des fractures parcellaires isolées des tuborosités. Les fractures articulaires, celles du col anatomique ou les fractures céphalo-tuborositaires à 2, 3 ou 4 fragments selon la classification de NIR.

Donc cette classification elle va donner une base de discussion au traitement et permet également des comparaisons cliniques. Donc NIR considère les quatre fragments susceptibles d'être déplacés. Nous avons le segment articulaire qui est le tiers d'une sphère donc c'est représenté ici par le chiffre 2, le troquin, le troquitaire et la diaphyse humérale.

Chaque entité fracturaire va présenter 2, 3 ou 4 fragments qui sont identifiés et classés en rapport avec le déplacement du fragment le plus important. Alors commençons par les fractures extra-articulaires. On va voir les fractures du tubercule majeur ou troquitaire.

Il correspond à un arrachement de l'insertion du tendon du supra-épineau. Donc on voit ici au milieu une luxation avec fracture du trochantère qui a été traitée chirurgicalement par un vissage. La deuxième fracture extra-articulaire c'est la fracture du tubercule mineur.

Elle est rare et c'est l'arrachement de l'insertion du muscle subscapulaire. La photo d'en haut elle montre un fragment de l'arrachement du tendon, de l'insertion du tendon supra-scapulaire. Donc le traitement est chirurgical.

La troisième entité c'est les fractures sous-tumorales. Elles peuvent être engrainées, ça veut dire elles sont non ou peu déplacées avec une persistance d'un contact qui permet la stabilité. On va étudier soit un déplacement qui est faible donc soit en abduction vers le dehors ou en abduction vers le dedans.

Ces fractures engrainées ce sont des fractures fréquentes. Le traitement il est en général orthopédique. Alors concernant les fractures non engrainées du col chirurgical de l'humérus, il n'y a pas ou peu de contact entre les fragments.

On va analyser le déplacement soit vers le dehors ou en dedans. Le plus souvent il y a une incarceration musculaire entre le foyer de fracture pourvoyeuse de pseudarthrose de ce type de fracture. Les fractures à trois ou quatre fragments, le tubercule majeur et le tubercule mineur sont séparés.

Le déplacement de la tête ou la calotte céphalique fait la gravité de la fracture. Elle peut en effet être désengainée, perdant tout contact avec la diaphyse ou même être énucléée voire luxer en arrière. Le risque de nécrose de la tête est important.

Concernant les fractures à quatre fragments, toute ostéosynthèse est difficile, précaire et les résultats sont incertains. Alors quels sont les moyens thérapeutiques? Donc il y a le traitement orthopédique, immobilisation coude au corps par une orthèse de l'épaule ou type du jarrier pour une durée de quatre à six semaines. Donc une immobilisation pendant les quatre premières semaines suivie d'une mobilisation passive pendulaire puis active.

Le traitement orthopédique est indiqué lorsque le déplacement est inférieur à un centimètre et lorsque l'angulation est de moins de 45 degrés. Alors concernant le traitement chirurgical, il consiste à réduire le foyer de fracture puis à le stabiliser par un moyen d'ostéosynthèse, soit par des broches, des plaques vissées donc comme on voit ici en bas et à droite, soit un encouage centromédullaire, c'est l'image du centre, soit des prothèses de l'épaule lorsque les fractures sont tricommissures à quatre fragments. En cas d'ostéosynthèse stable, il est parfois possible de débiter une rééducation précoce.

Lorsque la fracture est tricommissure, il faut savoir que pour les remplacements prothétiques ou les prothèses de l'épaule, elles peuvent être mises pour assurer le maintien de la fonction de

l'épaule, surtout chez le sujet plus âgé avec un os fragile, donc ostéoporose, ce qui permet le plus souvent une récupération plus rapide qu'avec une ostéosynthèse. Voici un traumatisme de l'épaule avec une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. Sur la radiographie de face, vous voyez qu'on n'arrive pas à identifier les différents fragments au niveau de la tête, et pour cela, on a eu recours à une tomodensitométrie qui a permis de montrer la lésion, donc une fracture luxation céphalo-tubérositaire à quatre fragments avec luxation de la tête en arrière.

Donc vous voyez ici, le traitement il est chirurgical avec mise en place d'une plaque vissée. Le risque chez ce patient, c'est la nécrose de la tête. Alors le troisième type des fractures de la ceinture scapulaire, c'est les fractures de la clavicule.

Les fractures de la clavicule, elles sont fréquentes, surtout pour le fracture moyen. Le déplacement est ici fréquent, donc ce sont des fractures qui sont le plus souvent déplacées. Vers le haut et l'arrière pour le fragment interne, c'est le rôle du muscle sternocleidomastoïdien.

Vers le bas et l'avant, c'est pour le fragment externe attiré par le deltoïde et le poids du membre supérieur. On va avoir une déformation en crosse qui rend le diagnostic évident. Donc voici la déformation qui est vue après la disparition de l'œdème et voici un déplacement qui est le plus souvent rencontré dans ce type de fractures.

Comment traiter ces fractures ? Donc le traitement est plus souvent orthopédique par des anneaux en 8 qui s'en misent pendant une moyenne de quatre semaines avec mobilisation du coude et de la main. Les complications des fractures et du traitement orthopédique, c'est le calvicieux et la pseudarthrose. L'intérêt de la rééducation pour éviter l'arrêteur de l'épaule.

Alors que pour le traitement chirurgical, il est indiqué lorsqu'il y a une menace d'ouverture cutanée, lorsqu'il s'agit d'une fracture ouverte, d'une épaule flottante, ça veut dire qu'il y a une fracture de la clavicule associée à une fracture de l'humérus, une lésion du dôme pleural, lésion vasculo-nerveuse, polytraumatisée ou polyfracturée. Alors l'éluxation sternoclaviculaire. Ce sont des lésions qui sont rares, de diagnostics difficiles.

Le plus souvent on a recours à une TDM parce que la radiographie de face ne met pas en évidence cette disjonction et la gravité, elle dépend du déplacement, surtout postérieur, de ces luxations. Alors ils sont classés en trois stades. Stade de l'entorse où il y a respect des ligaments, donc c'est juste la douleur, les patients ne viennent pas consulter à ce stade.

Le stade 2, c'est une subluxation, donc il y a une rupture, soit une rupture de la capsule et du ménisque, donc une interposition du ménisque costoclaviculaire qui va entraîner des fois des raideurs initiales au traumatisme. Le stade 3, c'est le stade de la luxation. Là on a une rupture des ligaments sternoclaviculaire et costoclaviculaire.

Donc le type de déplacement est important à connaître. Cliniquement, on va voir lorsqu'il y a une luxation antérieure, donc on va palper la clavicule, donc sous la peau. Le traitement, il est

souvent antalgique avec une immobilisation.

La réduction, elle est difficile à réaliser. Donc le traitement, il est le plus souvent orthopédique pour les luxations antérieures. Alors la difficulté, c'est pour les luxations postérieures où il y a le passage d'éléments vasculonerveux en arrière avec risque de compression vasculaire.

Là, le traitement, il s'impose quand il y a une complication, au risque de complications vasculaires voire nerveuses. Donc le traitement est chirurgical par réduction à ciel ouvert et stabilisation. Contrairement aux disjonctions sternoclaviculaire, les disjonctions acromioclaviculaire sont beaucoup plus fréquentes.

Elles surviennent surtout lors des traumatismes du moignon de l'épaule, un traumatisme à haute énergie, donc chute sur le moignon de l'épaule avec un examen clinique, une douleur avec impotence fonctionnelle. Plusieurs stades ont classé ces types de luxations, tout en sachant bien sûr qu'ils vont faire intervenir le ligament acromioclaviculaire et les ligaments coraco-claviculaires. Alors concernant le stade 1, c'est une stade d'endosse bénigne, il y a une intégrité des ligaments acromioclaviculaire et coraco-claviculaire.

Donc on va avoir juste une douleur avec une tumefaction, le plus souvent le traitement est orthopédique ou fonctionnel. Le stade 2, il va y avoir une déchirure des ligaments acromioclaviculaire mais respect des ligaments coraco-claviculaire. Le stade 3, il y a rupture des ligaments coraco-claviculaire, ce qui autorise l'ascension de la clavicule et cliniquement on va retrouver une touche de piano au niveau de la clavicule qui se laisse abaisser au doigt.

On va voir une manœuvre du tiroir de l'épaule antéropostérieure, donc on prend la clavicule entre la main et on va faire des va-et-vient en antéropostérieure avec réduction de la luxation pendant le tiroir postérieur. Il est assez minime, pas aussi important que pour le stade 4. Alors le stade 4, on va avoir le stade 3, ça veut dire une rupture des ligaments coraco-claviculaire et bien sûr acromioclaviculaire plus une luxation postérieure de la clavicule à travers le muscle trapèze. Donc on va avoir la clavicule qui va se luxer en arrière de la scapula.

Le stade 5, en plus du stade 3, on va avoir une désinsertion de la chape musculo- deltoïdo-trapézienne. Donc on va avoir une instabilité en antéropostérieure qui est importante. Alors que pour le stade 6, on va avoir en plus du stade 3, la luxation sous-coracoïdienne de la clavicule.

Donc la clavicule, elle va se placer en dessous de la pophyse coracoïde. Le diagnostic peut être réalisé sur la radiographie de l'épaule de face. Alors concernant le traitement des disjonctions acromioclaviculaire, on peut avoir donc le traitement orthopédique, c'est le repos avec écharpe pendant une durée de 10 à 15 jours avec un traitement médical, déglacage et une reprise rapide des activités.

Donc il est indiqué pour le stade 1, le stade 2, plus ou moins le stade 3 en fonction de la douleur et de l'examen clinique. Concernant le traitement chirurgical, il y a plusieurs modalités

thérapeutiques, notamment le brochage au bannage, le vissage coraco-claviculaire, voire le laçage coraco-claviculaire. Donc ils sont indiqués pour le stade 3, le stade 4, le stade 5 et le stade 6. Donc voici un patient polyfracturé suite à un accident de la voie publique avec un traumatisme de l'épaule qui a présenté multiples fractures, ce qu'on appelle le syndrome d'impaction homothoracique.

Donc c'est une épaule flottante avec fracture de la clavicule, fracture de la scapula, au niveau de la glène, du pilier externe, de l'acromion, fracture du tubercule majeur, fracture de la diaphyse humérale et fracture de côte. Donc voilà ce patient a résumé l'ensemble des lésions qu'on a vu tout à l'heure. Le traitement est chirurgical pour stabiliser la ceinture scapulaire.

Donc nous avons procédé à une stabilisation de la clavicule par une plaque vissée, de la scapula par une plaque vissée avec réduction de la cavité glénoïde, l'acromion par un embrochage au bannage, la diaphyse humérale par une plaque vissée. Alors concernant les fractures de côte, elles vont consolider sans aucun apport thérapeutique et pour le tubercule majeur, vu qu'il n'est pas déplacé, donc on ne l'a pas au stéosynthèse. Voilà donc ce sont des lésions qui sont complexes.

Le risque majeur ici c'est l'arrêt d'heure de l'épaule. Donc on arrivait à la dernière lésion des traumatismes de l'épaule, donc c'est la luxation de l'épaule. Donc on va voir la luxation antérieure de l'épaule et je vais donner un mot sur la luxation postérieure de l'épaule.

Alors la luxation antérieure de l'épaule, elle se définit par la perte de contact total et permanent entre la cavité glénoïde et la tête humérale. Celle-ci, elle va se déplacer en avant sous l'apophyse coracoïde. C'est une lésion qui est fréquente.

Elle se voit chez l'adulte jeune suite à un accident de sport, voire des accidents de la voie publique. C'est une urgence diagnostique mais aussi thérapeutique pour éviter des complications. Alors les complications la plus fréquentes c'est la récurrence.

Elle se voit beaucoup plus chez l'adulte jeune, alors que pour le sujet âgé c'est essentiellement l'arrêt d'heure articulaire, soit par rupture de la coire, soit par la capsulite rétractive. Le mécanisme, il est le plus souvent indirect, appuyé sur le bras en abduction, rotation externe et rétropulsion. Donc ceci va faire déplacer la tête en avant et donc le patient va avoir une attitude vicieuse particulière.

L'examen clinique va rechercher une douleur brutale. Le patient va venir le bras soutenu par le membre sain et l'attitude irréductible en abduction. A l'inspection et à la palpation nous allons rechercher les signes caractéristiques de la luxation de l'épaule qui sont le comblement du sillon deltopectoral par la tête humérale.

On va voir une saillie de l'acromion au signe de l'épaulette qui va signifier qu'il y a une vacuité de la glène et on va voir une sorte de coup de hache externe. Bien sûr il faut s'assurer de l'absence

de complications vasculonerveuses notamment le poux radial et le poux ulnaire, la sensibilité du moignon de l'épaule notamment à la recherche d'une paralysie du nerf axillaire ainsi que la motricité du moignon de l'épaule. Donc on va rechercher aussi s'il n'y a pas de troubles neurologiques en aval notamment au niveau de la main et des doigts à la recherche de lésions du plexus brachial.

Alors devant ce tableau on va demander un bilan radiologique fait d'une radiographie de l'épaule de face qui va rechercher la tête humérale le plus souvent déplacée en bas et en dedans sous l'apophyse coracoïde. Le profil si le patient arrive à le faire sinon on demandera une incidence de bloom oblique d'accord ce sont des rayons verticaux qui vont venir pour prendre l'articulation de haut et donc on va avoir un déplacement soit vers l'avant ou vers l'arrière donc il va nous montrer le déplacement de la tête. La radiographie va permettre aussi de rechercher des lésions associées notamment les fractures du trochytère de l'apophyse coracoïde voire des lésions de la tête humérale associée.

Sur le plan anatomopathologique nous allons rechercher les lésions capsuloligamentaires notamment la désinsertion du bourrelet glénoïdien au niveau du pôle antéro inférieur de la gléne en même temps que le ligament glénohuméral inférieur c'est ce qu'on appelle la lésion de bancarte qui lorsqu'elle est plus importante et va correspondre au décollement capsulopériosté de Broca et Hartmann. Donc c'est la rupture du ligament glénohuméral inférieur. Les lésions osseuses qui peuvent être associées notamment c'est les lésions du rebord antéro inférieur de la gléne et ce qu'on appelle l'écurement ou écaillure antéro inférieur c'est l'encoche de Malgaigne.

Donc on va rechercher la lésion de Broca ou décollement capsulopériosté de Broca ou la lésion de bancarte et la lésion du rebord antéro inférieur ou l'encoche de Malgaigne. Alors ces deux lésions lorsqu'elles sont importantes elles vont être source de récurrence, déluxation de l'épaule. Alors comment traiter la luxation de l'épaule? Donc c'est une urgence thérapeutique donc ne jamais réduire la luxation avant de faire la radiographie parce qu'on risque d'entraîner ou d'aggraver des lésions préexistantes.

Donc la réduction elle se fait en urgence sous anesthésie le plus souvent général. Il faut toujours s'assurer de la date du dernier repas pour ne pas entraîner ou aggraver l'intubation. La réduction elle se fait par traction, rotation externe et abduction ensuite rotation interne.

On va immobiliser le patient par une orthèse coup de corps pour une durée de trois semaines. Alors quelles sont les complications de déluxation de l'épaule? Donc les complications immédiates ce sont les complications vasculaires donc la compression de l'artère axillaire avec risque d'ischémie, des complications nerveuses notamment la compression du plexus ou des branches terminales du plexus brachial voire le nerf axillaire, la rupture de la coiffe des rotateurs, une luxation irréductible ou incohérentiable ça veut dire que si on essaye de la réduire elle se réduit puis elle se luxure facilement donc ça témoigne qu'il y a une interposition soit du labrum ou de la capsule entre la tête et la cavité glénoïde. Les complications tardives c'est la capsule

rétractile donc c'est l'épaule pseudo paralytique, les instabilités chroniques voire la luxation récidivante.

Alors un mot sur la luxation récidivante de l'épaule parce que c'est une complication fréquente après le premier épisode et donc le patient doit être mis au courant du risque de récurrence d'autant plus que l'âge est jeune moins de 20 ans. On doit rechercher l'hyperlaxité constitutionnelle qui est une source de récurrence majeure et lorsqu'il y a comme je dis tout à l'heure des lésions importantes notamment des grosses lésions de bancard voire celle de l'encoche de malgaigne. Alors ce sont des luxations récidivantes qui peuvent être traitées, qui sont traitées surtout chirurgicalement notamment par la butée coracoïdienne donc on prend la peau fesse coracoïde et on la met au niveau du rebord antéro inférieur de la glène par une ou deux vis pour éviter donc la luxation.

Soit par suture de la capsule donc qui est étanche avec réinsertion du décollement capsulaire ou capsulolabral au niveau du rebord antéro inférieur de la glène. Le traitement chirurgical il s'impose pour éviter l'évolution vers l'arthrose glénohumérale ou homarthrose. Donc on passe à la luxation postérieure de l'épaule donc je parle de la luxation postérieure de l'épaule parce qu'elle est importante à connaître car elle est plus rare que la luxation antéro interne et elle passe le plus souvent inaperçue.

Donc c'est pour cela que le diagnostic il est plus souvent non fait par le médecin et les complications par la suite elles vont devenir importantes avec risque d'instabilité et de luxation qui sont très difficiles à vivre pour le patient. Donc elle se voit le plus souvent au décours d'un accident de sport ou de la voie publique soit sur chute sur la main bras en rotation interne soit suite à un choc direct antérieur sur l'épaule. C'est une luxation qui se voit le plus souvent suite à des crises d'épilepsie ou suite à des électrocutions.

Donc attention chez les épileptiques il faut toujours penser au risque de luxation postérieure de l'épaule. L'examen clinique c'est une douleur qui est importante avec impotence fonctionnelle. Cliniquement on ne voit pas des signes habituels de la luxation antérieure donc l'épaule elle va être tu méfier mais on ne va pas avoir ni câblement du sillon ni signe de l'épaulette ou autre.

Le signe le plus souvent à rechercher c'est la rotation externe qui est impossible. C'est presque un signe pathognomonique de la luxation postérieure de l'épaule. Donc la recherche de la rotation externe qui est impossible et le patient il a une aptitude en adduction et en rotation interne.

Alors devant ce tableau on va demander un bilan radiographique d'une radiographie de face et donc attention quand on voit une radiographie pour quelqu'un qui n'est pas entraîné et qui n'a pas d'idée sur la luxation postérieure de l'épaule donc il risque de passer à côté de la luxation. Alors c'est une radiographie de face et de profil notamment l'incidence de bloom au bâtant qui va poser le diagnostic. Sur la radiographie de face donc on va avoir un aspect en double contour donc la tête humérale est à cheval sur le rebord postérieur de la glène et cet aspect de double contour

de la tête humérale sur la radiographie de face et on doit absolument avoir les deux clichés de face et de profil pour poser le diagnostic.

En cas de doute on demandera une TDM. La TDM donc là elle va montrer le déplacement de la tête en arrière donc comme on voit sur ces belles images tomodensitométriques. Alors le traitement comme pour toute luxation donc il faut faire une réduction sous anesthésie par traction abduction puis rotation externe ensuite une immobilisation en légère abduction et antépulsion donc par un cadre par des orthèses qui sont destinées à ce sens et toujours faire une radiographie de contrôle en post-opératoire aussi bien pour la luxation antérieure que pour la luxation postérieure.

Donc voilà on est arrivé à la fin de la séance et donc on a vu et passé en revue l'ensemble des lésions qui peuvent être rencontrées lors des traumatismes de l'épaule. Alors passons à notre cas clinique donc ce qu'on voit sur l'image patient de 24 ans, douleur de l'épaule suite à une chute sur la main lors d'un accident de sport. Alors à l'inspection c'est un patient avec attitude de traumatiser du membre supérieur et surtout en abduction.

On va rechercher le signe de l'épaulette donc on voit ici une saillie de l'acromion, signe de l'épaulette. On va rechercher ici l'encombrement du sillon deltopectoral, la vacuité de la glène. On va compléter l'examen par un examen vasculonerveux notamment le cou radial, le nerf axillaire, les restes du plexus parachial.

Donc on va examiner la main, voir la sensibilité, la mobilité en aval éliminant une lésion soit totale ou partielle du plexus parachial qui peut être associée à une luxation de l'épaule. On demandera une radiographie de face et de profil à la recherche de la luxation de l'épaule et on éliminera une fracture associée notamment la fracture du trochytère qui est la fracture la plus fréquente lors des luxations de l'épaule. Alors après le bilan radiologique donc on fera une réduction de la luxation sous anesthésie générale donc on demandera au patient la date du dernier repas, il doit être supérieur à 6 heures pour éviter les complications lors de l'intubation.

On peut éventuellement faire une réduction sans anesthésie mais là ça va demander la coopération du patient, elle doit être faite sans douleur. Après on demandera une radiographie de l'épaule, de contrôle ainsi qu'on va examiner le patient à la fin de la réduction pour voir s'il n'y a pas de lésion iatrogène notamment la paralysie du nerf axillaire. On va faire une immobilisation coup de corps par une orthèse pendant une durée de trois semaines.

La complication la plus fréquente et que le patient doit être remis au courant c'est la récurrence donc surtout si c'est le premier épisode et c'est une complication qui est redoutable, le patient il va voir des épisodes de luxation qui vont se rapprocher de plus en plus dans le temps et donc elle nécessitera lorsque la gêne est là un traitement chirurgical le plus souvent par une butée coracoïdienne. Donc en conclusion, c'est une pathologie qui est fréquente donc elle regroupe un certain ensemble de lésions qui sont plus importantes l'une que l'autre et le diagnostic est

essentiellement clinique confirmé par des radiographies. En cas de doute on peut demander une TDM de l'épaule.

La prise en charge est urgente pour éviter les complications et bien sûr le traitement doit être adapté à chaque type de lésion. Je vous remercie.